

Levensreddend handelen

De eerste stappen bij een slachtoffer, reanimatie en de AED, en de andere noodsituaties.

1 De eerste stappen

Bij een ongeval doe je als eerste dit: **kijken of de plaats veilig is**, voor jezelf en voor het slachtoffer. Een tweede slachtoffer helpt niemand. Zie je een **ongeval op de autosnelweg**, dan zorg je dus eerst voor je **eigen veiligheid**: stilstaan op een veilige plek, een hesje aan, de knipperlichten aan.

Het noodnummer voor een ziekenwagen is **112**, het Europese noodnummer voor ziekenwagen en brandweer. Voor de politie alleen bestaat ook 101.

Bij dat telefoontje vertel je **waar je precies bent, wat er gebeurd is** en **hoeveel slachtoffers er zijn en in welke toestand**. Wie schuld heeft, doet dan niet toe.

Of iemand bij bewustzijn is, ga je na doordat je de **persoon aanspreekt en zacht aan de schouders schudt**. Reageert er niets, dan **kijk je of het slachtoffer normaal ademt**: hoofd lichtjes achterover, naar de borstkas kijken en voelen of je adem op je wang voelt, tien seconden lang.

Is iemand **niet bij bewustzijn maar ademt hij normaal**, dan **leg je de persoon in stabiele zijligging en bel je 112**. In **stabiele zijligging** ligt het slachtoffer op de zij met het hoofd lichtjes achterover en de mond naar beneden, want **op de rug kan de tong of braaksel de luchtweg afsluiten**.

2 Reanimatie

Je start met reanimeren **als het slachtoffer niet reageert en niet normaal ademt**. Dan stuwt het hart het bloed niet meer rond.

Het ritme bij een volwassene is telkens **30 borstcompressies en 2 beademingen**, met **ongeveer 100 tot 120 compressies per minuut**, ongeveer twee per seconde.

Je legt de hiel van je hand **midden op het borstbeen**, je andere hand erbovenop, en duwt met gestrekte armen recht naar beneden, **ongeveer vijf centimeter diep**. Daarna laat je de borstkas volledig terugkomen.

Je **onderbreekt de hartmassage zo weinig mogelijk**, want elke onderbreking laat de bloeddruk wegzakken. Je gaat door tot de hulpdiensten er zijn of tot het slachtoffer weer normaal ademt. **Begint het weer normaal te ademen, dan leg je het in stabiele zijligging**.

Sta je er **alleen voor**, dan **bel je 112 met de luidspreker aan en begin je te reanimeren**: alarm en reanimatie moeten samengaan.

Reanimeren verhoogt de kans om een hartstilstand te overleven aanzienlijk. Elke minuut zonder hulp verkleint die kans sterk, dus beginnen is altijd beter dan wachten, ook als je het niet perfect doet.

3 De AED

AED staat voor **automatische externe defibrillator**. Het toestel **meet het hartritme en geeft enkel een schok als dat nodig is**; het beslist dus zelf.

Iemand zonder opleiding mag een AED gebruiken. Het toestel spreekt je stap voor stap toe, en hem niet gebruiken is het grootste risico.

Bij het gebruik hoort: het **toestel aanzetten en de aanwijzingen volgen**, de **elektroden op de ontblote borstkas kleven** en **niemand aanraken op het ogenblik van de schok**. De hartmassage gaat door tot het toestel vraagt om los te laten.

4 Bloedingen, brandwonden en verstikking

Bij een **hevige bloeding druk je met een propere doek stevig op de wonde**. Een afbindend verband wordt niet meer aangeraden. Je houdt het gekwetste lichaamsdeel bij voorkeur **hoger dan het hart**.

Een **brandwond** koel je **20 minuten met lauw stromend water**: water eerst, de rest komt later. Je doet er **geen boter, tandpasta of zalf** op, want vette stoffen houden de warmte vast. Een **blaar prik je niet open**: die is een steriel dekseltje over de wonde.

Verslikt iemand zich en kan hij nog **krachtig hoesten**, dan **laat je hem doorhoesten en blijf je erbij**. Lukt het hoesten niet meer, dan geef je **vijf slagen tussen de schouderbladen en daarna vijf buikstoten**, afwisselend tot het voorwerp eruit komt. Raakt de persoon buiten bewustzijn, dan start je met reanimeren.

5 Shock, breuken en andere noodsituaties

Tekens van **shock**: een **bleke, klamme huid**, een **snelle en zwakke pols** en **onrust, dorst of verwardheid**. De ademhaling wordt snel en oppervlakkig. Je **geeft niets te drinken**, houdt het slachtoffer warm en belt 112.

Bij een vermoedelijke **botbreuk laat je de arm zo liggen als hij ligt, steun je hem en bel je hulp**. Rechttrekken kan zenuwen en bloedvaten beschadigen. Bij een vermoeden van een **nek- of rugwonde laat je het slachtoffer liggen zoals het ligt, tenzij er onmiddellijk gevaar is**, want verplaatsen kan het ruggemerg beschadigen.

Bij een **epileptische aanval zorg je dat de persoon zich niet kan stoten en leg je iets zachts onder het hoofd**. Je houdt hem niet vast en steekt niets tussen de tanden. Na de aanval leg je hem in zijligging.

Bij een **hittestuwing of hitteslag** koel je de huid met **lauw water** en niet met ijs: ijs trekt de bloedvaten samen en dan kan de warmte er niet meer uit.

Klaagt iemand over **drukkende pijn in de borst die naar de arm uitstraalt**, dan **bel je 112, laat je de persoon stil zitten en blijf je erbij**. Dat kan een hartinfarct zijn.

In een eenvoudige **verbanddoos** horen **steriele compressen**, een **rol kleefpleister en een zwachtel** en **wegwerphandschoenen**. Een wonde spoel je met water, niet met alcohol. Handschoenen **beschermen zowel de helper als het slachtoffer**.

Het is nuttig dat zoveel mensen mogelijk kunnen reanimeren, want de **eerste minuten bepalen de kans om te overleven, en de hulpdiensten zijn er niet meteen**. Een omstaander overbrugt net die minuten.

Onthoud dit

- Eerst veiligheid, dan aanspreken en schudden, dan kijken of het slachtoffer normaal ademt.
- Bewusteloos maar normale ademhaling: stabiele zijligging en 112.
- Niet reageren en niet normaal ademen: reanimeren, 30 compressies en 2 beademingen.
- 100 tot 120 compressies per minuut, midden op het borstbeen, ongeveer vijf centimeter diep.
- Een AED geeft enkel een schok als het nodig is, en iedereen mag hem gebruiken.
- Bloeding: stevig op de wonde drukken en het lichaamsdeel hoger dan het hart houden.
- Brandwond: 20 minuten lauw stromend water, geen boter of zalf, en de blaar niet openprikken.
- Verstikking: laten hoesten; lukt dat niet, vijf slagen tussen de schouderbladen en vijf buikstoten.
- Shock of een vermoeden van nek- of rugwonde: niets te drinken geven, niet verplaatsen, 112 bellen.